Saúde Ocupacional

Exames de NR-7 e PCMSO, do admissional ao demissional

APASBS — Sistema de Gestão em Saúde
APAS Baixada Santista · Hospital Santo Expedito
Atualizado em 15/09/2026

Sumário

1. O que este módulo controla
Empresas, trabalhadores e fichas

2. Empresas e trabalhadores
Os dois cadastros que vêm antes

3. Preencher a ficha
As seis seções, na ordem do papel

4. Acompanhar e imprimir
Quem está vencendo, e a folha assinada

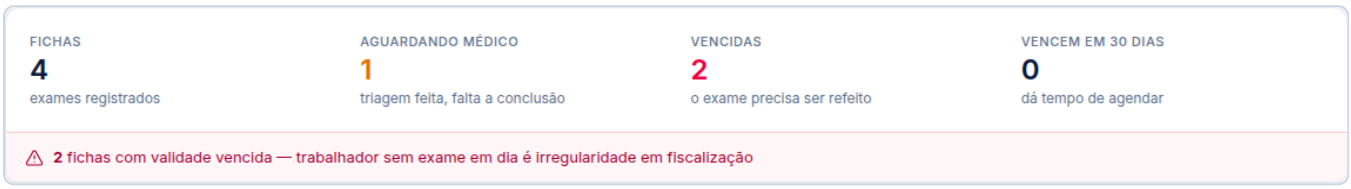
5. Entrega de atestado médico
Protocolo, comprovante e a 2ª via do colaborador

6. Perguntas rápidas

1 O que este módulo controla

Todo trabalhador precisa de exame médico ocupacional: um quando é admitido, outros de tempos em tempos, um quando volta de afastamento longo, um quando muda de função para outra com risco diferente, e um quando é desligado. É o que a **NR-7** exige e o que o **PCMSO** da empresa organiza.

O trabalho de verdade não é fazer o exame — é *saber de quem está vencendo*. Numa pasta de papel, isso só aparece quando a fiscalização pergunta.



Quantas fichas existem, quantas esperam o médico e quantas perderam a validade.

Como a informação é organizada

São três cadastros encaixados, do maior para o menor:

- **Empresa** — a empregadora. Cadastrada uma vez, escolhida depois numa lista, para o mesmo nome não virar três grafias diferentes no relatório.
- **Trabalhador** — a pessoa naquele emprego, com função, setor e data de admissão. Cadastrada uma vez; nome e CPF não se digitam de novo a cada exame.
- **Ficha** — um exame. É o prontuário em si, e é o que se imprime e assina.

> **Uma pessoa em duas empresas são dois cadastros.** Parece repetição, mas não é: função, setor e admissão são do *vínculo*, não da pessoa. Quem faz limpeza numa empresa e recepção na outra tem dois históricos ocupacionais distintos — e é assim que a NR-7 os trata.

Os cinco tipos de exame

- **Admissional** — antes de começar a trabalhar.
- **Periódico** — de tempos em tempos, conforme o risco da função.
- **Retorno ao trabalho** — depois de afastamento longo.
- **Mudança de risco** — quando a função muda para outra com exposição diferente.
- **Demissional** — no desligamento.

As quatro conclusões

Quem faz a triagem é a enfermagem do trabalho; quem decide se a pessoa pode exercer a função é o **médico do trabalho**. Por isso toda ficha nasce como **Aguardando médico** e só depois vira:

- **Apto** — pode exercer a função.
- **Apto com restrição** — pode, dentro de um limite que fica escrito na ficha.

- **Inapto** — não pode exercer aquela função.

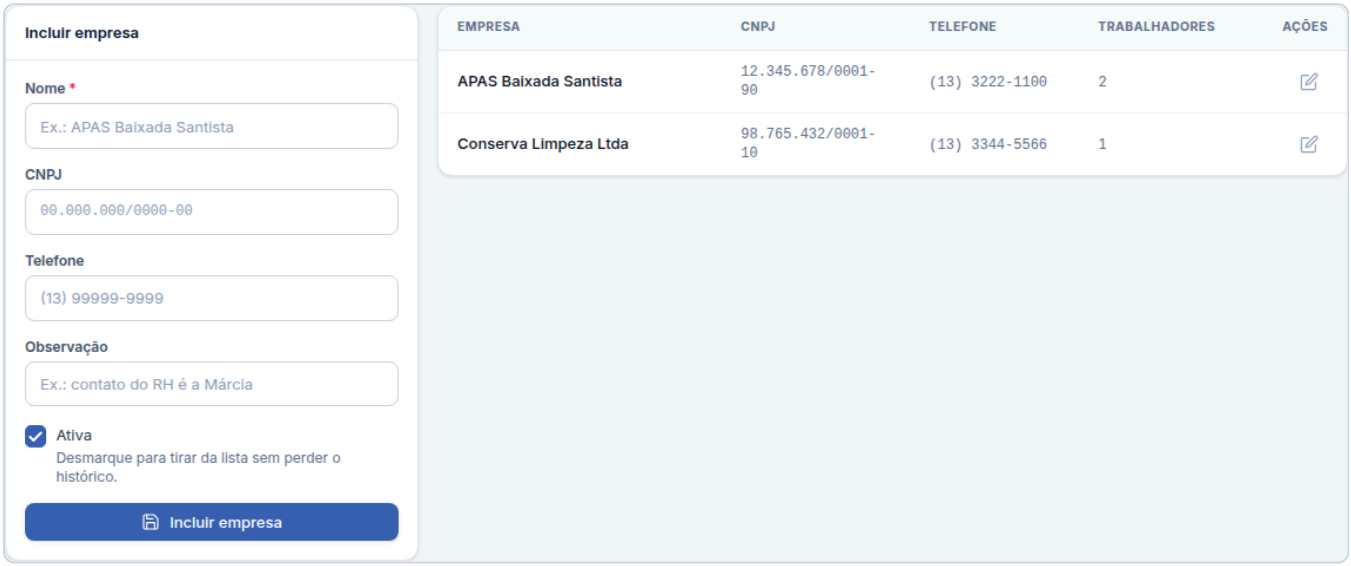
> **Isto é prontuário.** Dado de saúde é o grau mais sensível da LGPD, e a NR-7 manda guardar por **20 anos** depois do desligamento. Na prática, dentro do sistema: só quem tem permissão no módulo entra, cada impressão fica registrada na auditoria com o nome de quem imprimiu, e o sistema recusa apagar cadastro que tenha ficha.

2 Empresas e trabalhadores

Antes da primeira ficha, dois cadastros. São rápidos e se fazem uma vez só.

A empresa

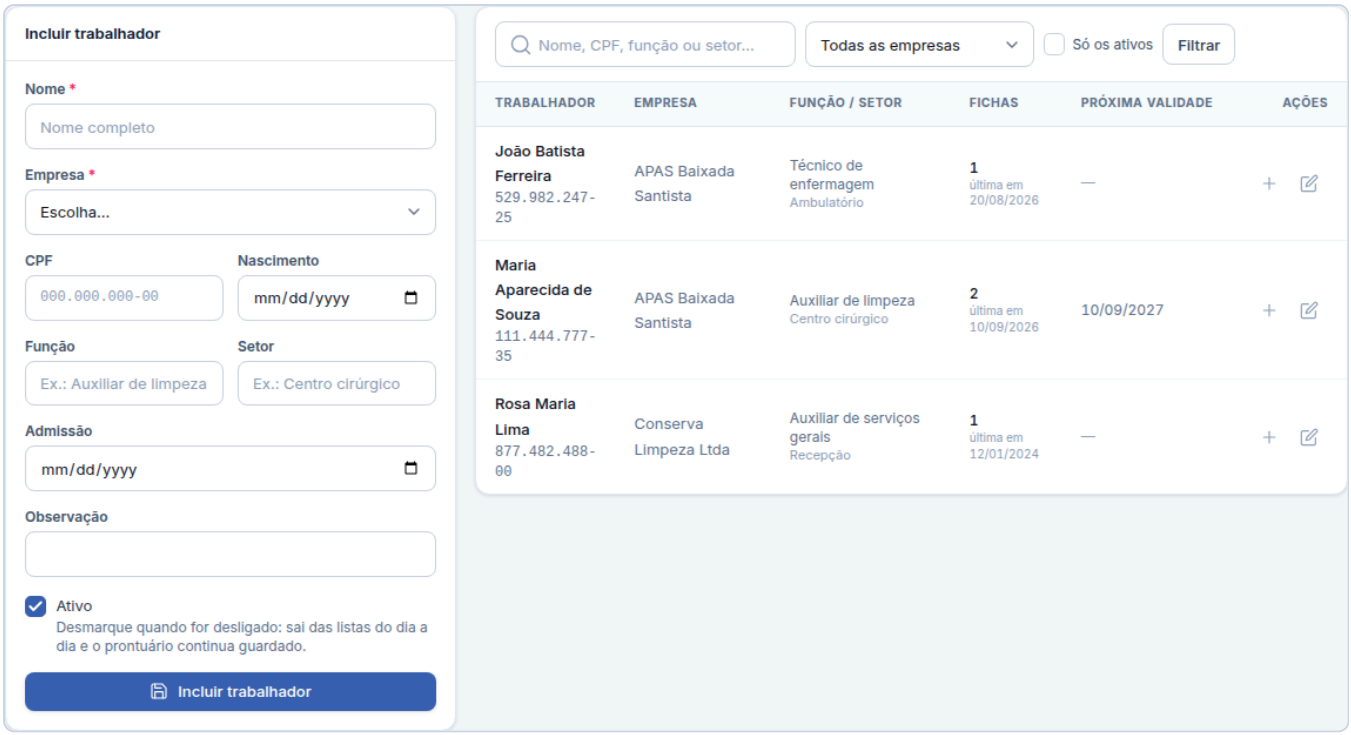
Em **Cadastros › Saúde Ocupacional › Empresas**. Só o nome é obrigatório; CNPJ, telefone e observação entram quando houver.



A coluna da direita diz quantos trabalhadores cada uma tem — e o número leva para a lista deles.

O trabalhador

Em **Cadastros › Saúde Ocupacional › Trabalhadores**. Nome e empresa são obrigatórios. O resto — CPF, nascimento, função, setor, admissão — pode entrar depois.



Quantas fichas cada um tem e quando vence o exame seguinte.

> **O CPF não é obrigatório, mas é conferido.** Acontece de o admissional ser feito antes de a papelada chegar, e travar o cadastro por isso faria anotar num papel para digitar depois. Mas o CPF que *vier* precisa ser um CPF de verdade: guardar número inválido é pior que não guardar nada — alguém vai usá-lo para achar a pessoa e não vai achar.

O mesmo CPF não entra duas vezes na mesma empresa. Se você tentar, o sistema recusa e oferece **abrir quem já existe** — quase sempre é a mesma pessoa sendo cadastrada de novo por engano.

Quem foi desligado

Desmarque **Ativo**. Ele sai da lista de escolha do dia a dia e o prontuário continua guardado — que é justamente o que a lei manda fazer por 20 anos.

> **Quem tem ficha não pode ser excluído.** O sistema recusa e diz quantas fichas existem. Não é implicância: apagar o cadastro levaria junto documento que a NR-7 obriga a guardar. Para tirar de circulação, desative.

A vida ocupacional da pessoa

Clicar no nome abre o cadastro com **todas as fichas dele**, da mais recente para a mais antiga.



> Admissional, periódicos e demissional na mesma tela — o que a pasta de papel nunca mostrou junto.

É daqui que sai a resposta para *"este exame dele piorou em relação ao anterior?"* sem procurar folha em arquivo.

3 Preencher a ficha

`Nova ficha` — ou o `+` na linha do trabalhador, que já abre com ele escolhido. As seis seções seguem a ordem do formulário em papel, para quem tem o modelo na cabeça não precisar procurar campo.

1 e 2 — Quem e que exame

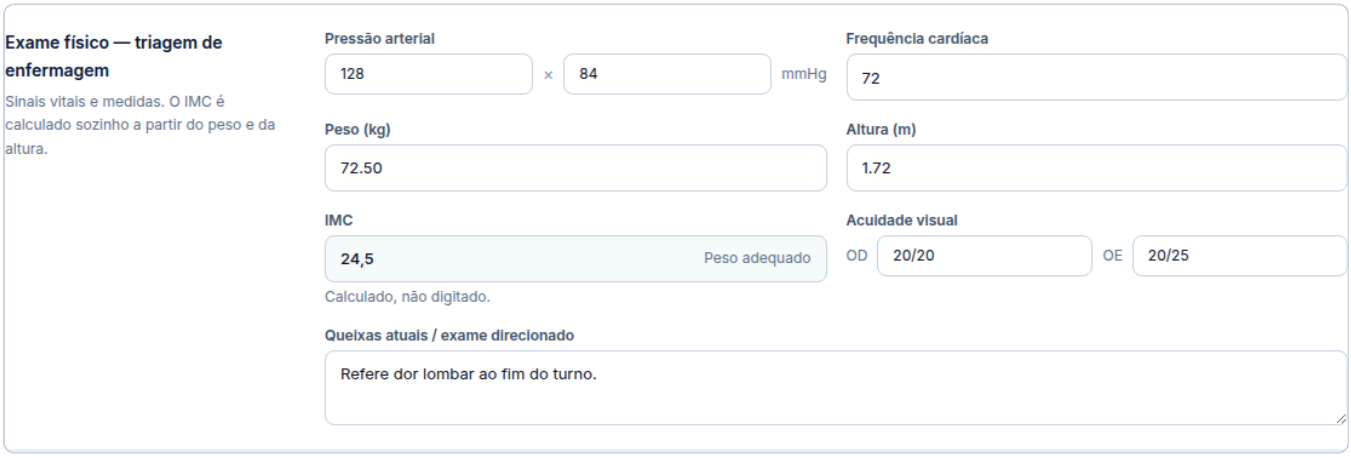
Escolha o trabalhador, o tipo de exame e a data. Nome, CPF, função, setor e admissão **não são digitados**: vêm do cadastro e saem sozinhos na impressão.

3 — Anamnese e riscos do PGR

A que a pessoa está exposta na função: ruído, químico, biológico, ergonômico, psicossocial. Marque quantos forem. É o que define quais exames complementares a NR-7 exige — quem trabalha com ruído precisa de audiometria, e assim por diante.

> **EPI tem três respostas, não duas.** Sim, Não e *Não informado*. Em branco quer dizer que não foi perguntado, que é diferente de perguntado e a pessoa não usa. Na fiscalização, essa diferença importa.

4 — Exame físico



O IMC aparece enquanto você digita o peso e a altura.

O **IMC é calculado, não digitado**, e vem com a faixa por escrito ao lado. Guardar o resultado no banco criaria duas verdades que divergem na primeira correção de digitação do peso — então ele é sempre recalculado a partir do que está lá.

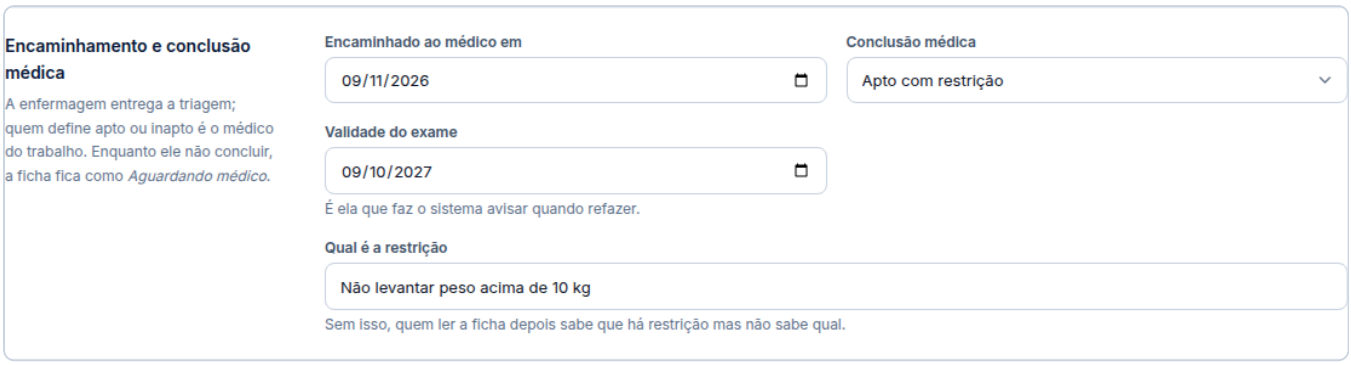
> **Vírgula ou ponto, tanto faz.** Escreva 1,72 como se escreve em português. E se digitar a altura em centímetros (172), o sistema entende assim mesmo.

5 — Exames complementares

A data de cada exame que veio anexado. Em branco quer dizer que aquele exame não foi pedido nesta ficha. O campo de observações da enfermagem é o recado para o médico do trabalho antes de

ele concluir.

6 — Encaminhamento e conclusão



> A restrição só aparece quando a conclusão é *Apto com restrição*.

A enfermagem costuma gravar a ficha em **Aguardando médico** e voltar depois, quando ele concluir. A ficha fica contada no cartão do topo até isso acontecer.

Preencha a validade. É ela que faz o sistema avisar quando o exame precisa ser refeito — sem ela a ficha não entra em nenhum aviso de vencimento. Se você concluir sem informar a validade, o sistema grava e avisa.

> **Escolheu "apto com restrição"? Escreva qual é.** Sem isso, quem ler a ficha daqui a dois anos sabe que existe uma restrição e não sabe qual — que é pior do que não ter registrado nada.

O que trava e o que só avisa

Trava só o que impede a ficha de existir: sem trabalhador, sem data, ou com sinal vital impossível (pressão de 900, altura de 8 metros — dedo escorregado no teclado). Essas faixas são largas de propósito: servem para pegar erro de digitação, não para discutir com quem examinou.

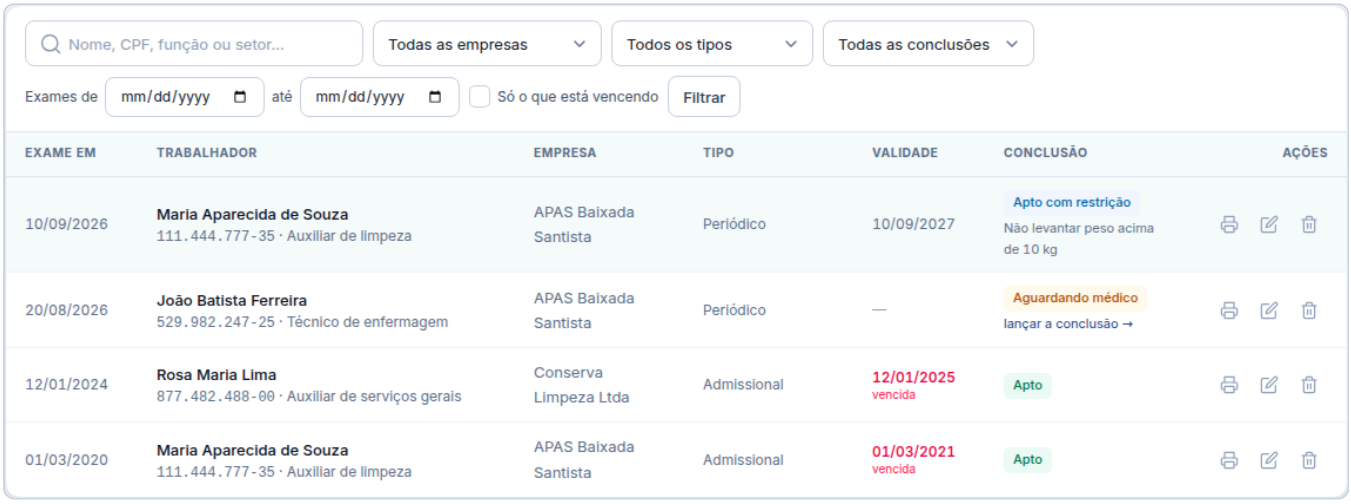
O resto **avisa e grava**: conclusão sem validade, restrição sem texto, validade anterior à data do exame, admissional depois da admissão. São regras nossas sobre dados de vocês — e recusar a gravação faria perder tudo que já tinha sido digitado.

4 Acompanhar e imprimir

Quem está vencendo

É a pergunta que o PCMSO faz o ano inteiro, e os quatro cartões do topo respondem sem contar linha. Cada um é clicável e filtra a lista.

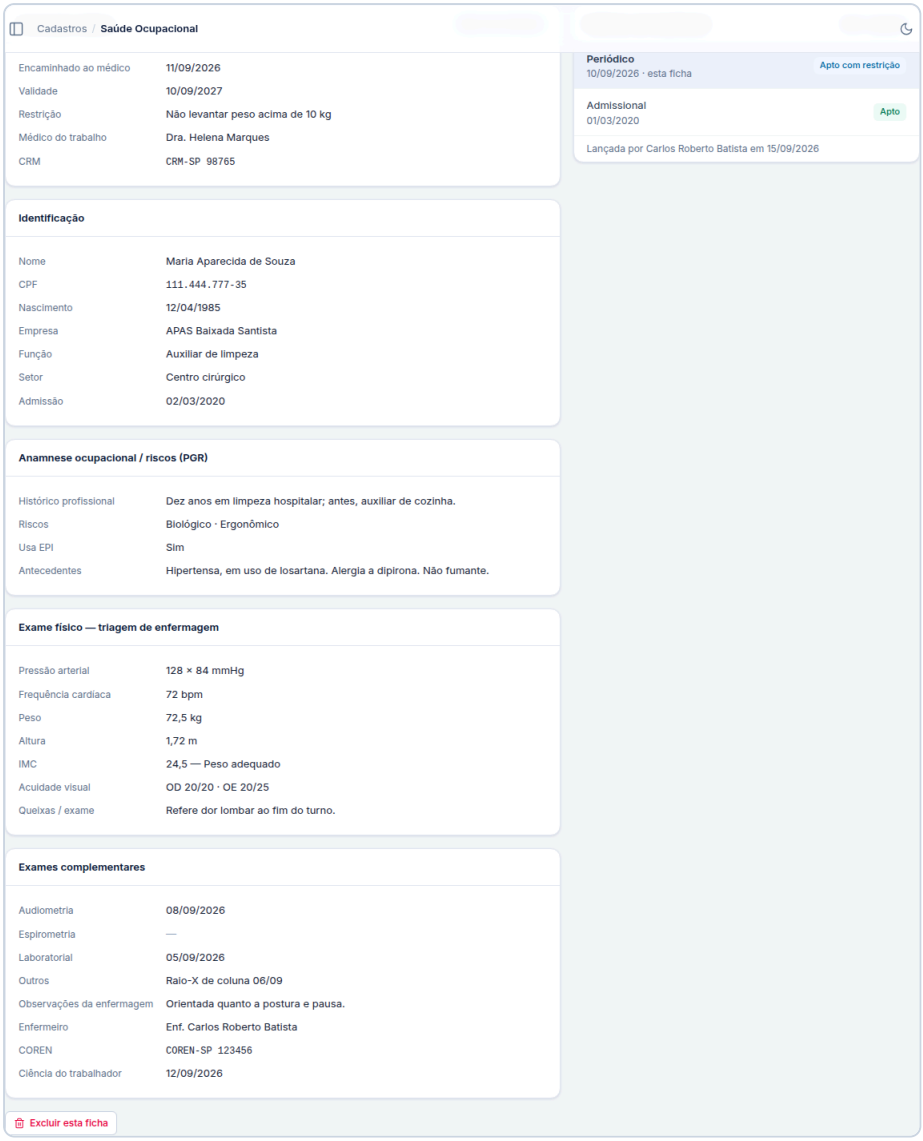
- **Aguardando médico** — a triagem foi feita, falta a conclusão. Na linha aparece **lançar a conclusão →**.
- **Vencidas** — em vermelho, com uma faixa de alerta embaixo dos cartões. Trabalhador sem exame em dia é irregularidade em fiscalização.
- **Vencem em 30 dias** — em âmbar. Ainda dá tempo de agendar.



A coluna de validade diz a situação pela cor, sem precisar abrir.

A busca procura ao mesmo tempo por **nome**, **CPF**, **função** e **setor**. Ao lado ficam os filtros por empresa, tipo de exame, conclusão e período — e a caixa **Só o que está vencendo**, que é a mais usada.

A ficha por dentro



A conclusão vem primeiro; o histórico da pessoa fica na coluna da direita.

A conclusão médica aparece no alto porque é o que quase todo mundo vem ver. À direita ficam as outras fichas do mesmo trabalhador — clicar em qualquer uma troca a tela sem perder o fio.

Imprimir

O botão `Imprimir` abre a ficha no **mesmo desenho do formulário em papel**, numa aba nova. Ela cabe em uma folha A4 e sai sem nada da tela do sistema em volta.



Imprimir Voltar à ficha

PRONTUÁRIO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Responsável Técnico: Enf. Ana Paula | COREN-SP 123456

CONFIDENCIAL — NR-7 / PCMSO / LGPD — Guardar por 20 anos

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome: MARIA DE SOUZA LIMA CPF: 529.982.247-25 Nasc.: __/__/__

Função: Técnica de enfermagem Setor: Centro Cirúrgico Admissão: 03/04/2023 Empresa: HOSPITAL SANTO EXPEDITO

2. TIPO DE EXAME

[ ] Admissional [X] Periódico [ ] Retorno ao trabalho [ ] Mudança de risco [ ] Demissional

Data do exame: 10/09/2026

3. ANAMNESE OCUPACIONAL / RISCOS (PGR)

Hist. Profissional: Dez anos em lavanderia hospitalar, cinco anos em rouparia, exposição contínua a produtos de limpeza e movimentação de cargas.

Riscos: [ ] Ruído [ ] Químico [X] Biológico [X] Ergonômico [ ] Psicossocial EPI: [X] Sim [ ] Não

Antecedentes / Medicações / Alergias / Hábitos: Hipertensão em tratamento com losartana 50 mg; alergia a dipirona; tabagista há 12 anos, 10 cigarros/dia; nega cirurgias prévias.

4. EXAME FÍSICO — Triagem de Enfermagem do Trabalho

PA: 120 x 80 FC: 72 Peso: 68,5 kg Altura: 1,65 m IMC: 25,2 Acuidade OD: 20/30 OE: 20/25

Queixas atuais / Exame direcionado: Refere dor lombar ao fim do expediente e formigamento em mãos pela manhã; nega febre ou perda de peso.

5. EXAMES COMPLEMENTARES ANEXADOS

Audiometria 20/08/2026 | Espirometria 20/08/2026 | Laboratorial 25/08/2026 | Outros: Raio-X de coluna lombar e hemograma completo anexados à pasta do PCMSO.

Observações da Enfermagem: Orientada quanto a pausas, alongamento e uso correto de luvas e máscara; encaminhada para avaliação médica.

6. ENCAMINHAMENTO MÉDICO

Encaminhado ao Médico do Trabalho em 11/09/2026 para definição de APTO/INAPTO

Conclusão Médica: [ ] APTO [X] APTO COM RESTRIÇÃO [ ] INAPTO Validade: 10/09/2027

Restrição: Não levantar peso acima de 10 kg e evitar flexão repetida de tronco por 90 dias.

Enfermeiro do Trabalho _____

Enf. Ana Paula · COREN-SP 123456 Assinatura/Carimbo

Médico do Trabalho _____

Dr. Carlos Andrade · CRM-SP 98765 Assinatura/Carimbo

Ciência do trabalhador: Data 12/09/2026 Assinatura: _____

APASBS — Ficha nº 1 · lançada por Administrador

Impresso por Administrador em 29/09/2026 13:22

> O que está preenchido sai escrito e sublinhado; o que está vazio vira linha para completar à mão.

As linhas de assinatura ficam em branco de propósito — é nelas que o enfermeiro, o médico do trabalho e o trabalhador assinam. Os nomes e os números de conselho saem embaixo, em letra menor.

> **Dá para imprimir a ficha em branco.** Uma ficha recém-criada, só com o trabalhador escolhido, imprime com todos os campos como linhas para preencher à mão — útil quando o exame acontece longe do computador. Depois é só digitar o que foi anotado.

> **Cada impressão fica registrada.** Imprimir é o momento em que o dado de saúde sai do sistema em papel, e a auditoria guarda quem imprimiu, qual ficha e quando. Em **Configurações › Auditoria**, a ação aparece como *imprimiu*.

5 Entrega de atestado médico

Quando alguém traz um atestado ao setor, o que o papel precisa provar é simples: que ele foi entregue, quando, e quem recebeu. É isso que esta tela registra — e é isso, e só isso, que o comprovante diz. Ele **não** é a validação do afastamento nem o abono: essa decisão é administrativa e vem depois.

O caminho é **Cadastros › Saúde Ocupacional › Atestados**. Na tela de um trabalhador também existe o botão **Entregar atestado**, que já abre com ele escolhido.

Registrar a entrega

São quatro blocos, na ordem do formulário em papel.

- **Colaborador** — escolhido no cadastro de trabalhadores. Matrícula, setor, cargo e empresa vêm de lá e saem impressos; não se digitam a cada atestado. Quem ainda não tem matrícula no cadastro, ganha o campo lá.
- **Dados do atestado** — emissão, início do afastamento, dias e retorno. O retorno é calculado de início + dias e continua editável: atestado de meio período e retorno em fim de semana existem, e a conta não sabe disso.
- **Entrega** — data, horário e forma (presencial, sistema, e-mail ou outro). Data e hora já vêm com o agora.
- **Recebimento** — quem recebeu o papel no setor, preenchido com quem está usando o sistema. Dá para trocar, e dá para deixar em branco: o comprovante sai com a linha para assinar à mão.

O **CID não é pedido**. Para comprovar a entrega ele não é necessário, e diagnóstico é o dado mais sensível que existe na LGPD — o que não se guarda não vaza.



O retorno aparece calculado assim que os dias são digitados — e pode ser corrigido.

O número do protocolo

O sistema numera sozinho, por ano: **2026/0001**, 2026/0002, e assim por diante. O número aparece ao gravar e é o que o colaborador leva escrito na 2ª via. Uma entrega excluída **não devolve o número para a fila** — ele já pode estar impresso na mão de alguém, e dois papéis com o mesmo protocolo é exatamente o que o comprovante existe para evitar.

O comprovante impresso

Uma folha só, com três partes separadas por linha de corte: a entrega assinada pelo colaborador, o recebimento assinado pelo setor e a 2ª via que fica com quem entregou. O que está preenchido sai escrito e sublinhado; o que está vazio vira linha para completar à mão.



ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

SETOR DE SAÚDE OCUPACIONAL

Hospital Santo Expedito | CNPJ: _____

PROTOCOLO Nº 2026/0001

DADOS DO COLABORADOR

Nome: MARIA DE SOUZA LIMA Matrícula: 2041

Setor: Centro Cirúrgico Cargo: Técnica de enfermagem Empresa: HOSPITAL SANTO EXPEDITO

DADOS DO ATESTADO

Data de emissão: 25/09/2026 Início do afastamento: 28/09/2026 Quantidade de dias: 4 Retorno previsto: 02/10/2026

Médico/Profissional emitente: Dr. Carlos Andrade CRM/Registro profissional: CRM-SP 98765

ENTREGA DO ATESTADO

Data da entrega: 29/09/2026 Horário: 09:15

Forma de entrega: [X] Presencial [ ] Sistema institucional [ ] E-mail institucional [ ] Outro: _____

Declaro que realizei a entrega do atestado médico ao Setor de Saúde Ocupacional, ficando registrado o recebimento do documento para as providências administrativas e ocupacionais cabíveis.

Assinatura do colaborador: _____

RECEBIMENTO — SAÚDE OCUPACIONAL

Recebido por: Enf. Ana Paula

Data: 29/09/2026 Horário: 09:20

Assinatura: _____

Observação: o presente documento comprova exclusivamente a entrega e o recebimento do atestado, não representando, isoladamente, sua validação ou aprovação.

corte aqui — 2ª via do colaborador

COMPROVANTE DO COLABORADOR — 2ª VIA

PROTOCOLO Nº 2026/0001 Colaborador: MARIA DE SOUZA LIMA

Atestado entregue em 29/09/2026 às 09:15 Quantidade de dias: 4

Declaro que o atestado médico foi entregue ao Setor de Saúde Ocupacional nesta data.

Responsável pelo recebimento: Enf. Ana Paula

Assinatura do responsável: _____ Assinatura do colaborador: _____

Data: 29/09/2026 | Comprova a entrega e o recebimento do atestado, não a validação do afastamento.

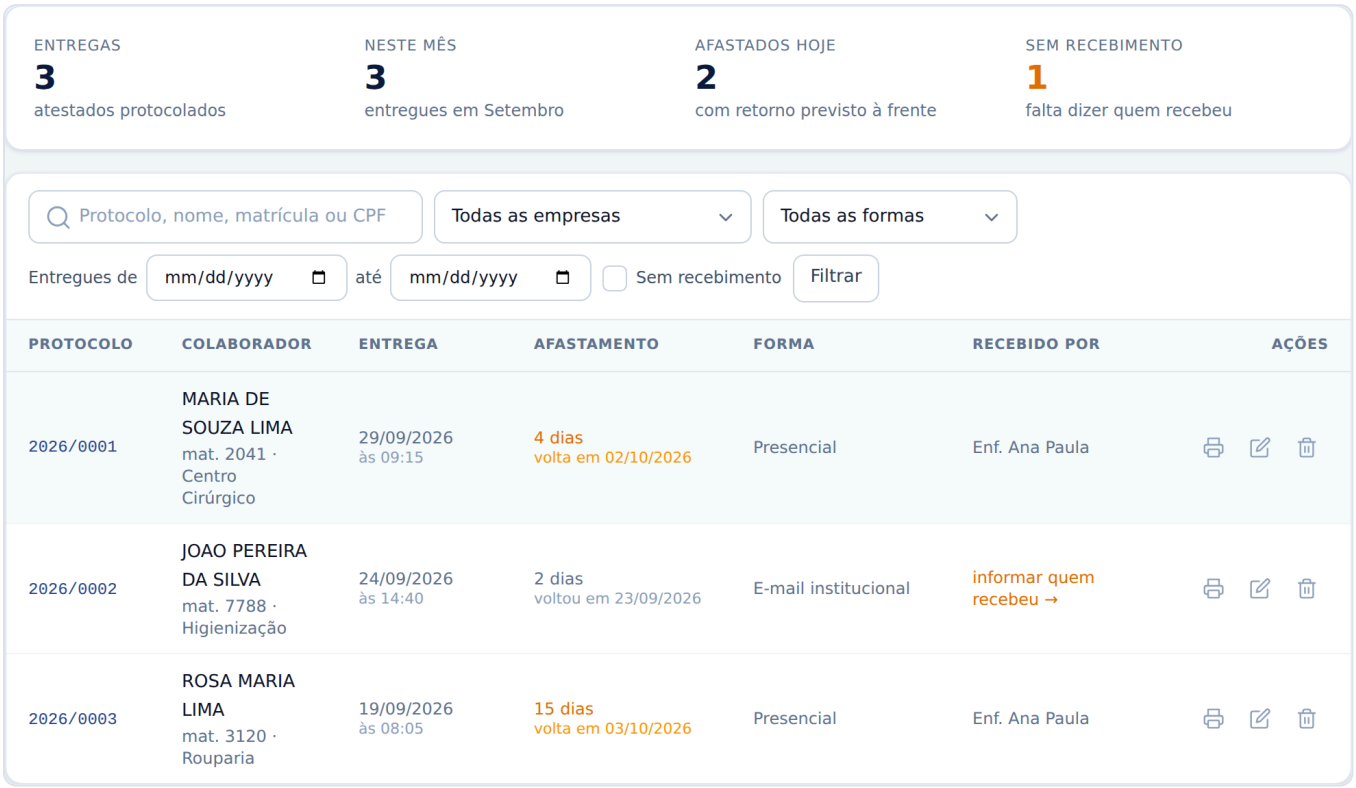
Hospital Santo Expedito — Protocolo 2026/0001 · registrado por Administrador

Impresso por Administrador em 29/09/2026 13:21

A folha inteira, pronta para assinar. A 2ª via se destaca pela linha pontilhada.

Acompanhar

- **Afastados hoje** — quem tem retorno previsto à frente. É a resposta para "quem está fora agora".
- **Sem recebimento** — entregas em que ninguém consta como quem recebeu. É a pilha que falta fechar, e a própria linha traz o atalho para completar.
- A busca procura ao mesmo tempo por **protocolo**, **nome**, **matrícula** e **CPF** — quem volta ao balcão costuma chegar com o número na mão.



Os cartões filtram a lista, e o afastamento em curso aparece em âmbar.

Excluir uma entrega é para o que foi lançado por engano. Quem tem entrega registrada não pode ser excluído do cadastro de trabalhadores — desmarque **Ativo** para tirá-lo das listas sem perder o histórico. Cada inclusão, alteração, exclusão e impressão fica na auditoria, com nome e hora.

6 Perguntas rápidas

A mesma pessoa trabalha em duas empresas. Cadastro duas vezes?

Sim, e é o certo. Função, setor e admissão são do vínculo, não da pessoa, e cada vínculo tem seu próprio histórico ocupacional. O CPF repetido só é recusado dentro da *mesma* empresa.

Preciso excluir um trabalhador e o sistema não deixa.

Ele tem ficha lançada. Prontuário precisa ser guardado por 20 anos, e apagar o cadastro levaria as fichas junto. Desmarque **Ativo**: ele sai das listas do dia a dia e o histórico continua guardado.

Lancei uma ficha no trabalhador errado.

Edite a ficha e troque o trabalhador — é o mesmo exame, registrado no lugar errado. Excluir só quando a ficha inteira foi lançada por engano.

O IMC não aparece.

Ele só aparece com peso *e* altura preenchidos. Confira também se a altura está em metros (1,72) — embora o sistema entenda 172 e converta sozinho.

O exame venceu e o trabalhador já refez. O que faço?

Crie uma **ficha nova**, não edite a antiga. Cada exame é um registro, e a sequência deles é o histórico que a NR-7 pede. A ficha vencida continua lá, e é isso que prova que o acompanhamento não teve buraco.

Como sei de quem vence o exame no mês que vem?

Clique no cartão **Vencem em 30 dias**, ou marque **Só o que está vencendo** na barra de filtros — ela traz o vencido e o que está para vencer juntos, que é a lista de quem precisa ser chamado.

Quem pode ver estas fichas?

Só quem tem permissão no módulo Saúde Ocupacional, dada em **Configurações › Permissões**. Como é dado sensível, vale conferir de tempos em tempos quem está com acesso — e lembrar que ver não é a mesma permissão que editar ou excluir.

Quem mexeu numa ficha?

Em **Configurações › Auditoria**. Cada inclusão, alteração, exclusão *e impressão* fica registrada com o nome e a hora.